

26 - 02- LES TROUBLES DE LA MICTION - Pr. Lakmichi

Ce cours de stémiologie et urologie a titulé « Les troubles de la médecine ». C'est un cours qui a une extrême importance parce que les troubles de la médecine constituent généralement un motif de consultation très, très fréquent dans l'urologie et qui révèle plusieurs pathologies et on en cherche par la suite. On démarre le cours en définissant tout d'abord la médecine normale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une médecine normale ? Une médecine normale, c'est l'action d'uriner.

Elle doit être volontaire, elle doit être indolore, s'effectuer sans difficulté, selon une fréquence compatible, avec une autonomie suffisante entre deux médecins et permet une évacuation vésicale complète, ce qui définit le confort médical. Alors, notez des éléments très importants, c'est que la médecine doit être volontaire, très important, sans douleur, sans gêne, sans difficulté et son but, son objectif ultime, c'est de vider la médecine, une évacuation complète, vésicale complète, ce qui définit le confort médical. La pollacurie, la pollacurie comme premier signe des symptômes urologiques dans les troubles médicaux est définie par l'émission anormalement fréquente avec une émission de petite quantité d'urine.

Elle peut être dure, c'est-à-dire au cours de la journée, on mesure ça en interrogeant le patient, il faut des intervalles entre deux missions, il doit être généralement moins de deux heures pour avoir ces troubles médicaux, ou bien nocturnes, facilement mesurables, on demande au patient simplement combien de fois vous vous êtes levé la nuit pour uriner, et généralement les patients s'y viennent très bien. Et au-delà de deux levées par nuit, elle est considérée pour la cure nocturne ou ce qu'on appelle mixturie. Donc c'est un motif de consultation, comme le reste des troubles médicaux, qui est très fréquent, et le plus fréquent plutôt, il entrave l'activité et perturbe le sommeil, et donc ça a un impact direct sur la vie active sociale du patient.

Elle peut être une maladie légère et donc supportable, comme elle peut être intermittente et modérée, comme elle peut être intense. Les étiologies, généralement, sont des étiologies, c'est-à-dire des causes ou des pathologies, qui vont irriter la vessie, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un symptôme irritatif. Et en premier lieu, on trouve les pathologies lésionnelles, ce qu'on appelle les instabilités détruisorielles, comme secondaire à une infection, comme les cystiques, ou bien secondaire à une tumeur de la vessie, corps étranger, quatre poules, etc., ou bien une cause neurologique ou idiopathique.

Il y a les pathologies prostatiques, qui viennent en premier lieu, par exemple, de prévalence en matière de prolapxie, mais mécanisme, c'est l'instabilité détruisorienne, et sa cause, c'est généralement accompagné par le trouble de la guidance, comme la prostate peut induire un obstacle, et donc le trouble de la guidance lésionnelle. C'est un symptôme qu'on peut aussi rencontrer lorsque la vessie de capacité diminue, c'est une chose qu'on voit de plus en plus rarement, c'est-à-dire une atteinte secondaire, une atteinte tuberculose ou bilharzienne, ou bien une radiothérapie périméridienne, qui vont induire une sclérose de la paroi vésicale, et donc une

réduction du volume vésical. Assez rarement, et peut être secondaire à un désordre psychosomatique d'une patiente.

Nos diagnostics différentiels, et on n'en a pas beaucoup, généralement, quand on est en présence d'un patient qui a un bon volume de durée, ce qu'on appelle la polyurie, c'est une durée très très importante, et donc le patient est obligé d'aller à chaque fois peu ruiner avec une urine qui est normale, mais à chaque fois, à chaque émission, à chaque mixtion. Cependant, sur 24 heures, c'est un patient qui peut ruiner 6 litres, 8 litres, jusqu'à 12 litres, généralement, qui ont des pathologies secondaires, par exemple un diabète sucré. Le deuxième symptôme, c'est la dijurie.

Alors, la dijurie, comme son nom l'indique, avec le préfixe 10, c'est gêne, gêne à uriner, donc c'est un patient qui a une émission qui est très lente, pénible, en plusieurs temps, et non douloureuse, nécessitant des poussées abdominales pour aboutir à une mixtion. Donc, le patient, il va pousser, il va céder avec l'augmentation de sa pression abdominale, il va pousser sur la parente vésicale, et donc, on va pouvoir réussir à avoir quelques coups pour uriner plus ou moins convenablement. Cliniquement, c'est un jeu urinaire qui est faible, et lent, avec l'obligation de pousser pour initier et de poursuivre à une mixtion, l'obligation aussi d'attendre avant que la mixtion ne commence, et souvent, ce sont des mixtions en plusieurs temps, avec des coups retabulatoires désagréables, mixtions en plusieurs temps.

Pourquoi ? Parce que le patient n'a pas à vider complètement sa mixtion, et donc, c'est possible de garder ce qu'on appelle un résidu post-mixtionnel, et rapidement, ce résidu post-mixtionnel devient très important, et donc, induire une envie d'aller encore uriner, et donc, il y a déjà le lien, c'est pour ça que, généralement, la dysurie est accompagnée d'une prolatérie chez les patients. Elle peut passer inaperçue, et se révéler par ses conséquences, ses dysuries, dysurie, vraiment, c'est son dernier obstacle de sous-vésicale, généralement, souvent, et donc, ça va induire une stagnation des urines, ce qu'on appelle le résidu post-mixtionnel, comme on l'a dit, qui est plus ou moins important, ou, carrément, une rétention aiguë du nez, c'est-à-dire, le patient n'y vit plus longtemps, c'est sûr, c'est un vessie qui est complètement bloqué, le patient ne peut plus vider sa vessie, ou bien, on peut avoir une distension chronique de la vessie, ce qu'on appelle une rétention chronique de la vessie, qui peut, donc, se révéler par une émission par engorgement. Une émission par engorgement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une évacuation, à chaque fois, du trop-plein vésical.

La vessie est complètement remplie, je vous rappelle que la capacité vésicale est de 300 ml, généralement, ces 300 ml, le patient le garde, ces 300 ml dans sa vessie, et à chaque fois que les urines viennent des nerfs brétéraux, ce trop-plein qui vient, donc, dans la vessie, va se vider, et donc, ce qu'on appelle la mixtion par regorgement. Et ce symptôme-là, il est mesuré par ce qu'on appelle la débitmétrie qui permet de chiffrer la digébrille exactement sans débitmètre. Il y a différents types de débitmètre qui peuvent mesurer le débit de la mixtion, et généralement, quand

on a une débitmétrie inférieure à 10 ml par seconde, c'est une digébrille qui est nette, et qui devient sévère, ou très sévère, quand la digébrille, quand la débitmétrie est inférieure à 5 ml par seconde.

Les étiologies. Alors, les étiologies, généralement, font des obstacles sous-vésicaux, comme on a dit. Alors, il y a un obstacle en premier lieu, par exemple, de prévalence, il y a des obstacles prostatiques, en l'occurrence, l'hypertrophie bénigne de la prostate ou carrément le cancer de la prostate.

Il y a des sténoses de l'urètre, des sténoses du col vésical, il y a des calculs enclavés au niveau du col vésical et de l'urètre, une hypoactivité vésicale, ça c'est très important, c'est une étiologie, généralement, qui est très sous-estimée, et qui a regard d'intérêt ces dernières années, c'est que le moteur vésical, c'est-à-dire le muscle vésical qui est le détruteur, il est fatigué du fait de l'âge, etc. Donc, quand on a un léger obstacle, c'est un sujet qui est très très âgé, il peut, donc, facilement être responsable d'une dysurie voire même d'une rétention. N'oublions pas en dernier les causes neurologiques, les causes neurologiques peuvent être congénitales comme Akis, congénitales comme le spina bifida, la génèse sacrée, Akis, en premier lieu, on trouve les traumatismes vertébraux, médulaires, bien après, les compressions médulaires, les limites et les troubles de la coordination des hypo-sphinctalités, des synergies des hypo-sphinctalités.

Le troisième symptôme qui est l'urgenterie, qui est l'obligation d'uriner dans les secondes qui suivent la perception des urines, il y a des patients qui viennent et ils vous disent dès qu'une goutte tombe dans la lessie, je dois courir, chercher des toilettes pour vider la lessie et malheureusement il y a quelques gouttes qui sortent, ce n'est pas vraiment une vraie lession, ça, c'est une définition typique de l'urgenterie ça c'est un mot, c'est une expression qui vient de la littérature anglo-saxonne parce qu'avant on l'appelait intérieorité mixionnelle mais les anglo-saxons les traduisent mieux donc ça rappelle mieux la réalité des choses, c'est un patient qui a une urgence à uriner, c'est pour ça qu'on appelle l'urgenterie. Les étiologies, alors les étiologies toujours on reste dans le cadre des pathologies qui vont hériter la vessie donc à chaque fois qu'il y a un organe qui est de la prostate qui est un organe hypertrophique de la prostate ou cancer de la prostate ou une pathologie qui n'est pas écrite sur un diapositive qui est la prostatite très importante donc la prostatite c'est une pathologie prostatique et du fait de l'inflammation il va aussi hériter la vessie et par conséquent donner le type d'urgenterie. Les pathologies infectieuses en plus de la prostatite on trouve les cystites pathologies inflammatoires de la vessie souvent d'ailleurs généralement sont utilisées par carrières les cystites non infectieuses interstitiales ou post-radiques les corps étrangers quelques-unes de vessies visées à l'urinaire causes neurologiques sclérose en place en plaques en premier et en dernier les causes qu'on n'arrive pas à caractériser quand on est dans la casse hypothalamique les fuites urinaires alors les fuites urinaires il y en a deux types alors les fuites selon l'orifice d'où les urines vont fuir alors si les urines vont fuir par l'orifice naturel qui est le nerf ou l'étral on parle d'incontinence urinaire donc perte par fuite involontaire des urines par le nerf ou l'étral c'est une incontinence typique les fuites

urinaires vaginales ou autres ce sont des orifices extra-anatomiques extra-urinaires et après là on se trouve dans le cas des fissures fissures neuro-génitales soit visico-génitales le plus souvent ou exceptionnellement les fissures urethrales le plus souvent l'incontinence urinaire cliniquement ce sont comme on a dit des fuites urinaires par le nerf ou l'étral à l'occasion d'un effort de tout soulèvement de charge etc ce sont les incontinenances urinaires à l'effort à l'opposé on trouve des fuites urinaires permanentes par le nerf ou l'étral qui se trouvent plutôt dans un cadre d'insuffisance sphinctérienne c'est-à-dire le sphinctère urinaire ne marche plus hein pour plusieurs raisons qu'on verra dans le chapitre pathologie au cours de la septième année mais là on est dans le chapitre sémiologie il faut savoir qu'on a à notre stade uniquement les deux types d'incontinence urinaire on a on a les incontinenances urinaires par incontinence urinaire à l'effort à l'opposé des fuites urinaires permanentes et des incontinenances urinaires permanentes généralement par insuffisance sphinctérienne les fuites urinaires par fistules urogenitales cliniquement ce sont des fuites avec perte de la mixture normale c'est tout à fait raisonnable logique il y a le réservoir qu'on n'arrive plus à remplir parce qu'il y a des fuites il y a une communication entre le réservoir vésical et la cavité vaginale à travers un orifice et donc les oignons ils passent de la vessie vers le vagin et donc la vessie elle se vide à travers le vagin et par conséquent il y a une perte de la mixture normale les fuites urinaires avec conservation de la mixture lorsqu'il y a une fistule entre l'ureterre et le vagin et donc la vessie continue à se remplir par notre mer urétérale et donc il y a un certain volume d'urine qui peut garder le patient mais souvenez-vous que c'est une situation vraiment très exceptionnelle le plus souvent on voit les fistules physico-vaginales la piorie c'est un autre symptôme des troubles médeceinaux il se définit par la présence de pus dans les oignons c'est un aspect très important des urines prévenues en rapport avec une infection urinaire le diagnostic se fait en deux étapes c'est d'abord d'affirmer la piorie et par la suite de la recherche à la cause alors comment affirmer la piorie c'est bien entendu c'est les examens microscopiques de laboratoire ce qu'on appelle l'examen cytobacterie commence d'abord par un examen microscopique à la recherche de leucocytes atterrés quant à l'animation de leucocytes savoir le débit des leucocytes qui doit être le plus souvent à 5000 leucocytes par minute et l'examen bactériologie des urines qui vise à chercher des germes en cause une piorie sans germes on peut tomber sur cette infection là elle est recherchée surtout lorsqu'on est en présence d'une tuberculose ou bien une antibiothérapie qui a été démarrée au préalable afin de réaliser le prélèvement et donc on a tué les bactéries avant de faire le prélèvement l'aide de galopsie différentielle c'est assez exceptionnel c'est la phosphaturie et la chulurie la phosphaturie c'est le trouble qui disparaît avec l'aide de l'acide acétique et la chulurie c'est la lave dans les urines qui sont des urines les étiologies les causes toutes les causes favorisant la stagnation des urines et l'inflammation urinaire les calculs urinaires l'astéronome du bérêt l'HBP l'altération d'uroteline qui présente les cancers du vessie ou bien une malformation urinaire l'hématurie alors c'est un signe très alarmant c'est un patient généralement qui vient vous confronter avec un tableau d'anxiété et de peur c'est un patient qui urine le sang qui a des urines rouges et généralement la définition c'est l'émission d'urine mêlée de sang présente le sang dans les urines c'est la définition tout simplement en rapport souvent avec une infection des voies

urinaires ou bien des reins ça impose toujours une enquête étiologique le diagnostic positif d'abord l'examen macroscopique des urines et l'examen microscopique qui va donc confirmer la présence d'urines rouges avec un certain débit qui est au delà de 5000 par minute dans les urines le diagnostic topographique la chronologie du saignement c'est très important il faut différencier entre hématurie initiale hématurie terminale hématurie totale alors l'hématurie initiale c'est une origine uretroprostatique l'hématurie initiale c'est-à-dire les premiers jets quand le sang vient mêler avec des urines dans les premiers jets lors de la mixtion l'origine c'est une origine uretroprostatique quand le sang vient mêler avec des urines en fin de mixtion c'est une origine qui est desicale l'hématurie totale quand le sang vient mêler avec des urines lors de la mixtion c'est une origine uretroprostatique quand le sang vient avec des urines en fin de mixtion c'est une origine vient mêler avec des urines pour compléter toujours il y a aussi des examens paracliniques à savoir l'échographie duuroscania qui va explorer tout l'appareil urinaire et le maître examen c'est un examen endoscopique qui est la cystoscopie qui va déceler la présence de lésions lésicales ou bien une éjaculation sanglante par amère urétérale témoignant d'une atteinte du haut appareil urinaire homolatéral ou bien éjaculation sanglante par amère urétérale auquel cas on est en présent d'une infection néphrologique et pas urologique infection du parenchyme prérenal ça c'est très important pour faire la différence des choses une hématurie d'origine urologique c'est une lésion de l'urothélium c'est à dire la muqueuse urothéliale qui tapisse les voies excrétrices savoir en premier lieu on va voir les causes les psychologies à l'opposé d'une infection du parenchyme prérenal c'est une hématurie néphrologique alors l'autre différence aussi c'est l'hématurie d'origine urologique c'est une hématurie caillotante l'hématurie d'origine néphrologique c'est une hématurie non caillotante très important comme c'est une cellulologie alors à différencier bien entendu l'hématurie d'une coloration par les animaux ou les médicaments et à différencier aussi surtout de l'urethroragie d'un coulement de sang par le nerf urétral en dehors des médecins les causes de l'hématurie sont les causes urologiques comme on l'a dit c'est à dire des lésions de l'urotélion au niveau de la vessie ce sont les tumeurs de la vessie les tumeurs rénales les tumeurs de la voie c'est triste plutôt les thias urinaires les cystites ou bien les infections urinaires spécifiques tuberculose goupilles d'arthrosurine les causes générales les maladies hémorragiques traitements anticoagulants et les causes néphrologiques syndrome néphrologique et autres néphropathiques dans les roulettes la pneumaturie c'est très simple c'est l'émission de simultanées de gaz et d'urine c'est souvent l'expression d'une tumeur urodécrite et c'est facilement reconnu par le malade l'anurésie une émission nocturne incontrôlée et involontaire elle peut révéler une anomalie urinaire parfois traduction souvent d'un désordre psychique blocage émissionnel alors le blocage émissionnel c'est très simple c'est l'interruption brusque de l'émission jusqu'alors normale elle est due le plus souvent à la présence d'un corps étranger à travers l'échelle qui s'engage dans le recte ou dans le col de l'échelle ce sont des fractures de vessie en conclusion les troubles émissionnels peuvent compromettre sérieusement la qualité de vie des patients ils sont souvent le reflet d'un désordre organique qu'il faudrait savoir rechercher et diagnostiquer afin de garantir une prise en charge thérapeutique adaptée